TEMA 8 · Enfermería basada en la evidencia, guías y vías clínicas. Igualdad, violencia de género y derechos LGTBI

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: EBE, fuentes, búsqueda, lectura crítica, niveles de evidencia, GPC, mapas y vías clínicas · Bloque B: LO 3/2007, Ley 7/2007, LO 1/2004 y Ley 4/2023

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
EBE / PBE	Enfermería Basada en la Evidencia / Práctica Clínica Basada en la Evidencia	Decidir con la mejor investigación, la experiencia y las preferencias del paciente
GPC	Guía de Práctica Clínica	Recomendaciones para decidir qué hacer
JBI	Instituto Joanna Briggs	Centro australiano de EBE
PICO / PECO / SPIDER	Paciente o población, Intervención, Comparación, *Outcome* (resultado) / con Exposición / formato cualitativo	Plantillas de la pregunta clínica
MeSH / DeCS	*Medical Subject Headings* / Descriptores en Ciencias de la Salud	Tesauros (listas oficiales de palabras clave) de PubMed / de LILACS y BDENF
CINAHL, LILACS, BDENF, CUIDEN, ENFISPO	Bases de datos bibliográficas	Ver tabla de A2
DOI	*Digital Object Identifier*	Código único y permanente de un documento digital
CASPe	*Critical Appraisal Skills Programme* España	Plantillas de lectura crítica
PRISMA	*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*	Cómo publicar revisiones sistemáticas
IC / RR / OR	Intervalo de Confianza / Riesgo Relativo / *Odds Ratio*	Se leen en el forest plot
SIGN, GRADE, CEBM, CTFPHC	Sistemas de niveles de evidencia y grados de recomendación	Ver A4
AGREE II	*Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation*	Evalúa la calidad de las GPC
CISNS / IACS	Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud / Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud	De ellos depende GuíaSalud
NANDA-NOC-NIC / HCE	Diagnósticos, resultados e intervenciones enfermeras / Historia Clínica Electrónica	Lenguaje de los mapas de cuidados
CE	Constitución Española	Art. 14: igualdad ante la ley
LO 3/2007	Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres	Discriminación, planes de igualdad (B1)
RDL 6/2019 / RD 901/2020	Real Decreto-ley de igualdad en el empleo / Real Decreto de planes de igualdad	Permiso por nacimiento / planes de igualdad
Ley 7/2007 (Murcia)	Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia	Igualdad y recursos para víctimas en Murcia (B2)
LO 1/2004	Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	Violencia de la pareja o expareja sobre la mujer (B3)
Ley 4/2023	Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI	Despatologización, terapias de conversión (B4)
LGTBI	Lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales	
CAVI / EMAVI	Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia / Equipos Municipales de Atención a la Violencia contra la Mujer	Recursos de Murcia

Abreviaturas de las normas: **LO** = Ley Orgánica (la aprueban las Cortes por mayoría absoluta; regula derechos fundamentales); **RDL** = Real Decreto-ley (norma urgente del Gobierno con fuerza de ley).

A1. Concepto y modelos de implementación de la EBE

- Origen: Medicina Basada en la Evidencia, **Universidad de McMaster** (años 90; **Sackett** y Guyatt): "utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible".
- **Gálvez Toro (Fundación Index)**: 4 componentes: **investigación**, **experiencia clínica**, **preferencias del paciente** y **recursos disponibles**.
- Fases (5 A): **Ask** → **Acquire** → **Appraise** → **Apply** → **Assess**, es decir: 1) formular la pregunta, 2) buscar la evidencia, 3) **lectura crítica**, 4) aplicarla en la práctica y 5) evaluar el resultado.

Modelo	Claves
Iowa (Titler)	**Organizacional**; arranca con **desencadenantes (triggers)**: **del problema** (datos internos: caídas, bacteriemias, quejas) o **del conocimiento** (nueva GPC, normativa externa); prueba piloto en una unidad
Stetler	**Individual** (pensamiento crítico de la enfermera); 5 fases: preparación, validación, evaluación comparativa, aplicación y evaluación
ACE Star (Stevens)	5 puntas: descubrimiento, resumen, traslación (guías), integración y evaluación
Joanna Briggs (JBI)	Australia; ciclo de generación, síntesis, transferencia y utilización
Larrabee (2009)	Modelo de cambio de la práctica basado en la evidencia en **6 pasos**: valorar la necesidad de cambio, localizar la mejor evidencia, analizarla críticamente, diseñar el cambio, implantarlo y evaluarlo, e integrarlo y mantenerlo

TRAMPAS DE EXAMEN

! Desencadenante interno (aumento de caídas) = **enfocado en el problema**.

! Cambio individual basado en un artículo = **Stetler**, no Iowa.

A2. Preguntas, fuentes y bases de datos

- Preguntas **background** (básicas: qué, cómo, por qué) → fuentes **terciarias** (libros). Preguntas **foreground** (decisión clínica) → formato **PICO** y bases de datos.
- **Tipos de pregunta clínica**: de **intervención o tratamiento**, de **diagnóstico**, de **pronóstico** y de **etiología o riesgo** (si una exposición causa un daño: p. ej., cocaína en el embarazo y problemas de aprendizaje del niño).
- Formatos: **PICO**/PICOT/PICOS (eficacia), **SPIDER** (cualitativa; su "E" es **evaluación**) y **PECO** (riesgo o etiología; su "E" es **exposición**).

Fuente	Qué es	Ejemplos
Primaria	Estudio original	Ensayos clínicos, cohortes, casos y controles
Secundaria	Sintetiza fuentes primarias	**Revisiones sistemáticas, metaanálisis, GPC**
Terciaria	Conocimiento consolidado	Libros, enciclopedias, diccionarios

- **Pirámide de las "6 S" de Haynes** (se empieza a buscar por arriba): **Sistemas** (cúspide: sistemas informatizados de **ayuda a la toma de decisiones** unidos a la historia clínica) → **Sumarios** (UpToDate, GPC basadas en la evidencia) → **Sinopsis de síntesis** (resumen de lo que concluye una revisión sistemática para apoyar una decisión clínica) → **Síntesis** (revisiones sistemáticas) → Sinopsis de estudios → **Estudios** (originales, fuentes **primarias**: la **base**).
- **Literatura gris**: tesis, actas de congresos, informes; se busca en las revisiones sistemáticas para evitar el **sesgo de publicación**.

Base de datos	Claves
PubMed/MEDLINE	Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.; tesauro **MeSH** (inglés)
Cochrane Library	Revisiones sistemáticas (CDSR) y registro de ensayos (CENTRAL)

Base de datos	Claves
WoS / Scopus	Citas y factor de impacto
CINAHL	La mayor específica de **enfermería**
LILACS / BDENF	Latinoamérica / enfermería de Brasil; tesauro **DeCS**, trilingüe: **español, portugués e inglés**
CUIDEN	**Fundación Index (Granada)**; mucha literatura gris y cualitativa
ENFISPO	Universidad **Complutense**: enfermería, fisioterapia y podología
Dialnet / MEDES / CUIDATGE	La Rioja / Fundación Lilly / Rovira i Virgili

- **Metabuscadores** (buscan a la vez en muchas fuentes): **Trip Database** (resultados por colores), **Epistemonikos** (Chile, revisiones sistemáticas) y **SUMSearch 2**. La **Cochrane no es un metabuscador**. MeSH y DeCS son de consulta gratuita.
- **Gestores bibliográficos** (guardan referencias y crean la bibliografía): Mendeley, Zotero, EndNote, **RefWorks**. Feedly no lo es (es un lector de noticias RSS); eXeLearning sirve para crear materiales educativos y BibTeX es un formato de referencias.
- **DOI** (*Digital Object Identifier*): identificador **único y permanente** de un contenido digital que permite localizarlo; vale para artículos, libros (puede convivir con el ISBN), datos... **no solo para artículos de revista**.
- **Cita bibliográfica**: la mención **dentro del texto** a una idea o frase ajena que remite a su fuente. **Referencia bibliográfica**: los datos completos de esa fuente en la lista final.
- Búsqueda: **AND** (restringe: la intersección de dos círculos), **OR** (amplía), **NOT** (excluye); **truncamiento *** (enferm*), **comodín ?** (p?ediatrics), comillas (frase exacta), etiquetas [ti], [ab], [au], y paréntesis: dolor AND (niños OR neonatos). **Operadores de proximidad** (no booleanos): NEAR, ADJ, NEXT.

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Las GPC son fuentes secundarias, no primarias.**

! MeSH = PubMed. DeCS = LILACS/BDENF.

A3. Lectura crítica, revisiones sistemáticas y metaanálisis

- Lectura crítica: **validez** interna, **importancia** de los resultados y **aplicabilidad**.
- **CASPe** (de CASP, Oxford): plantillas por diseño, de 10-11 preguntas en 3 bloques: **A, validez** (las **2 primeras** son de **eliminación**), **B, resultados**, **C, aplicabilidad**. Es una herramienta del **lector**; las guías de redacción para autores son CONSORT, STROBE, PRISMA o COREQ.
- **Revisión sistemática**: método explícito y reproducible (frente a la revisión **narrativa**, subjetiva). **Metaanálisis**: combina estadísticamente los resultados. **Revisión panorámica** (*scoping review*): precursora de la sistemática; hace una **evaluación preliminar del volumen de evidencia** sobre un tema, la **mapea** e identifica **lagunas** de conocimiento.
- **PRISMA 2020** (sustituye a PRISMA 2009 y antes a QUOROM): **27 ítems** y diagrama de flujo de **4 fases**: identificación, cribado, elegibilidad e inclusión. Extensiones: PRISMA-P (protocolo, registro en PROSPERO), PRISMA-ScR (revisiones panorámicas).
- **Forest plot**: cada estudio es un cuadrado (tamaño = peso) con su intervalo de confianza (IC); el **diamante** es el resultado global. Línea de no efecto: **1** para RR/OR y **0** para diferencias de medias. Si el IC **toca o cruza** esa línea, no es significativo.
- **Funnel plot**: la **asimetría** indica **sesgo de publicación**.

A4. Niveles de evidencia y grados de recomendación

Sistema	Claves
Jovell y Navarro-Rubio (1995)	**9 niveles** (I ensayo clínico grande ... IX anecdótico) y grados **A-E**. **C = evidencia insuficiente**; **E = buena evidencia para excluir** (es dañino)

Sistema	Claves
CTFPHC (Canadá, prevención)	A buena a favor, B moderada a favor, C conflictiva, D moderada en contra, E buena en contra, **I insuficiente**
SIGN (usado por GuíaSalud)	Niveles 1++ a 4 (los "−" no sirven para recomendar); grados **A-D** y √ buena práctica clínica
GRADE (OMS, Cochrane)	Ensayos clínicos parten de **alta**, observacionales de **baja**; bajan por sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión o sesgo de publicación; suben por efecto grande (RR > 2 o < 0,5; muy grande si > 5 o < 0,2), dosis-respuesta o confusión residual. Calidad alta, moderada, baja o muy baja. Recomendación **fuerte** o **débil/condicionada**
CEBM Oxford	Niveles 1 a 5 con subniveles (1a revisión sistemática de ensayos clínicos, 1b ensayo clínico, 1c "todo o nada") y grados A-D
JBI (FAME)	**F**easibility (viabilidad), **A**ppropriateness (adecuación), **M**eaningfulness (significado para el paciente), **E**ffectiveness

- En la **pirámide de la evidencia**, arriba están los **metaanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos** de alta calidad (SIGN 1++).
- **Calidad en GRADE**: **alta** = el efecto real está muy cerca del estimado; **moderada** = probablemente cerca, pero podría ser sustancialmente distinto; **baja** = el efecto real **puede ser sustancialmente diferente** del estimado; **muy baja** = probablemente sea sustancialmente diferente.
- **Recomendación fuerte en GRADE**: para los **pacientes**, casi todos querrían la intervención; para los **clínicos**, **la mayoría de los pacientes deberían recibirla**; para los **gestores**, puede adoptarse como política en la mayoría de situaciones. (Que distintas opciones sirvan a distintos pacientes, o que haga falta debate, es propio de la recomendación débil.)
- **Ventajas de GRADE**: proceso **transparente** para pasar de la evidencia a la recomendación; valora de forma explícita la **importancia de los resultados**; **reconoce explícitamente los valores y preferencias**; útil para revisiones sistemáticas, evaluaciones de tecnologías y guías.

TRAMPAS DE EXAMEN

! En Jovell, la **E** no es "insuficiente": significa **desaconsejar** por daño.

! "Viabilidad, adecuación, significado" = **JBI**.

A5. Integración en la práctica y herramientas de estandarización

- **Barreras**: del profesional (resistencia, idioma, falta de tiempo), de la organización (sobrecarga, falta de liderazgo y acceso) y de la propia evidencia (resultados ambiguos). **Modelo KTA** (*Knowledge to Action*, Graham): creación del conocimiento y ciclo de acción.

Herramienta	Responde a	Ámbito	Flexibilidad
GPC	**¿Qué hacer?**	Nacional (**GuíaSalud**)	Alta
Vía clínica	**¿Cuándo y quién?**	Hospital o servicio; **multidisciplinar**	Media (registra variaciones)
Mapa de cuidados	Plan enfermero estandarizado	Lenguaje **NANDA-NOC-NIC** en la historia clínica electrónica (Selene, OMI-AP)	—
Protocolo / procedimiento	**¿Cómo hacerlo?**	Unidad; unidisciplinar	**Nula** (obligatorio)

- **GPC** (definición del Instituto de Medicina de EE. UU., IOM): recomendaciones elaboradas sistemáticamente para **ayudar a profesionales y pacientes a decidir**; también sirven como **medida de control de la calidad** (SMS 2022). **GuíaSalud**: organismo del **Consejo Interterritorial del SNS (CISNS)**, con centro coordinador en el **Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud**.
- **AGREE II**: **23 ítems en 6 dominios** (alcance y objetivos; participación de los implicados; **rigor en la elaboración**; claridad; aplicabilidad; independencia editorial), escala **Likert de 1 a 7**, **2-4 evaluadores** independientes y 2 ítems

globales.

- **Vía clínica**: para procesos de **alta frecuencia**, alto riesgo o coste y **evolución predecible** (prótesis de cadera o rodilla, colecistectomía programada, parto eutócico). Componentes: **matriz temporal**, **hoja de variaciones**, **hoja de información al paciente** y **encuesta de satisfacción**.

CLAVE PARA RECORDAR

- Números: PRISMA **27** ítems; AGREE II **23** ítems y **6** dominios; CASPe **10-11** preguntas.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Si el paciente con vía clínica tiene fiebre, la vía **no se suspende**: se anota en la **hoja de variaciones**.

BLOQUE B · Igualdad, violencia de género y derechos LGTBI

B1. LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

- Persigue la igualdad **real y efectiva** (más allá de la igualdad ante la ley del art. 14 de la Constitución). Principio rector (el que guía toda la ley): **transversalidad**, es decir, tener en cuenta la igualdad en todas las políticas.

Concepto	Definición	Ejemplo
Discriminación directa (art. 6.1)	Trato menos favorable por razón de sexo	"Solo enfermeros varones para el turno de noche"
Discriminación indirecta (art. 6.2)	Norma **aparentemente neutra** que perjudica a un sexo sin justificación	Exigir 1,75 m de altura para la UCI; disponibilidad total a quien no tenga cargas familiares

- **Art. 8**: el trato desfavorable por **embarazo o maternidad** es discriminación **directa**. **Art. 9**: **indemnidad** (protección frente a represalias por reclamar). **Art. 10**: nulidad de los actos discriminatorios; **inversión de la carga de la prueba** (es la empresa quien debe probar que no discriminó). **Art. 11**: **acciones positivas** (medidas a favor de las mujeres, razonables, proporcionadas y mientras dure la desigualdad).
- Riesgo durante el embarazo y la lactancia (art. 58): adaptación → cambio de puesto → suspensión con el 100%. **Vacaciones** (art. 59): se disfrutan en otro periodo si coinciden con estos permisos, aunque haya terminado el año.
- **Permiso por nacimiento (RDL 6/2019)**: **16 semanas** para cada progenitor (igualadas del todo desde **2021**), **individual e intransferible**, al 100%; las **6 primeras** tras el parto son **obligatorias** e ininterrumpidas; las otras 10 se distribuyen hasta los 12 meses.
- **Planes de igualdad (art. 46; RD 901/2020)**: obligatorios con **50 o más trabajadores** (o si lo exige el convenio o la autoridad laboral). Diagnóstico negociado de **9 materias** (selección, clasificación, formación, promoción, condiciones, **auditoría retributiva**, corresponsabilidad, infrarrepresentación y **acoso**). Inscripción en registro público; **Distintivo de Igualdad**.
- **Empleo público (Título V)**: Unidades de Igualdad y **presencia equilibrada** (disposición adicional 1.ª): ningún sexo **por encima del 60% ni por debajo del 40%**.
- **Género y salud** (SMS 2019): el género crea desigualdades por sí solo y **agrava** las debidas a nivel socioeconómico, edad, etnia, discapacidad u orientación sexual. Sumar el rol reproductivo (cuidados) al productivo (empleo), la **doble jornada**, **empeora** la salud de la mujer; no la mejora.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Planes de igualdad: **50** trabajadores (250 y 100 son cifras antiguas).

! Las semanas del permiso por nacimiento **no se pueden ceder** al otro progenitor.

! Tribunal de 5 miembros: como máximo **3** del mismo sexo.

B2. Ley 7/2007 de Murcia y II Plan de Igualdad del SMS

- **Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia**. Transversalidad en planificación, presupuestos, ejecución y evaluación. El **Instituto de la Mujer** es el organismo gestor: le corresponden la **ordenación, planificación y programación** de las políticas de igualdad (no al Instituto de Servicios Sociales).
- **Plan General de igualdad**: lo aprueba el Gobierno regional **cada legislatura**, con la participación de las demás administraciones, y se evalúa; las administraciones deben presupuestar su ejecución.
- **Acoso (art. 22)**: **acoso sexual** (naturaleza sexual) y **acoso por razón de sexo** (desprecio por ser mujer, por embarazo). Ambos son **discriminación directa** y **falta muy grave**. Protocolo del Servicio Murciano de Salud (SMS): denuncia confidencial, comité investigador paritario con prevención de riesgos, **medidas cautelares**, informe y equipos de apoyo a la víctima. En la Administración General del Estado, el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo se aprobó por el **Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo**.
- **Art. 25 · salud**: integrar la perspectiva de género es **obligatorio**: datos desagregados por sexo, sesgos diagnósticos (infarto en la mujer), programas específicos y formación en violencia de género.
- **Asistencia a las víctimas (arts. 47-48)**: las administraciones dan **asistencia integral** para paliar las consecuencias físicas y psíquicas (seguridad, salud, necesidades económicas, jurídicas y sociales). Se benefician **la víctima, los menores bajo su patria potestad, guarda o tutela y cualquier otra persona dependiente de ella**. Recursos:
  - **Dispositivo de atención urgente**: atención médica, jurídica y psicológica inmediata y **acogida inmediata en centros de emergencia**.
  - **Casas de acogida**: centros de **estancia media** (alojamiento, protección, apoyo psicológico, laboral y educativo). **No** son el dispositivo de atención urgente.
  - **Pisos tutelados** (temporales, autogestionados) y **centros de atención especializada** (los CAVI).
- Organización según el SMS 2022: el 112 atiende también las llamadas de violencia de género en la Región; las políticas de prevención dependen de la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
- **II Plan de Igualdad del SMS**: plantilla de alrededor de **70% mujeres** con techo de cristal persistente; **10 ejes**. Destacan el **eje 5** (conciliación y corresponsabilidad) y el **eje 6** (**especial protección**: traslados urgentes y adaptación de jornada para víctimas de violencia de género **sin merma retributiva**).

B3. LO 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral contra la violencia de género

- **Art. 1**: violencia de un **hombre** sobre una **mujer** que sea o haya sido su **cónyuge o pareja**, **aun sin convivencia**. Incluye violencia física, psicológica (también **luz de gas**), sexual, económica y **vicaria** (art. 1.4: dañar a los hijos u otras personas para herir a la mujer). Las agresiones de desconocidos se rigen por otras normas (p. ej., libertad sexual).
- **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**: competencia **penal y civil** (divorcio, custodia, pensiones).
- **Art. 15**: formación sanitaria para el diagnóstico precoz. **Art. 16**: **Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS)** (protocolos e indicadores).
- **Art. 19**: asistencia social integral (información, atención psicosocial, asesoría jurídica, acogida); **19 bis**: atención sanitaria integral.
- **Derechos laborales (arts. 21-26)**: reducción o reordenación de jornada, **movilidad geográfica sin necesidad de vacante**, suspensión con reserva de puesto y **faltas justificadas** por informe de servicios sociales o sanitarios.

Protocolo común sanitario

1. **Detección**: hematomas en distintos estadios, lesiones defensivas, lesiones en el embarazo, infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados repetidos, somatizaciones, ansiedad, depresión, consumo de psicofármacos; acompañante que no se separa y responde por ella.
2. **Entrevista**: en **privado**, separándola con una excusa (electrocardiograma, constantes), sin juicios ni presión.
3. **Valoración del riesgo**: **riesgo vital** → no dejarla salir, avisar a las fuerzas de seguridad (112, 091, 062) y parte de lesiones; **violencia aguda sin riesgo inminente** → **parte de lesiones** al Juzgado de Guardia aunque no quiera denunciar (relato literal entre comillas); **violencia crónica** sin lesión aguda → apoyo y derivación a trabajo social.

- **Solo sospecha y ella lo niega** (SMS 2022): **escucha activa** y **apoyarla en las decisiones que tome**, sin presionarla para denunciar; registrar la sospecha en la historia y ofrecer seguimiento.
- Recursos en Murcia: **CAVI** (psicóloga, abogada y trabajadora social; **sin necesidad de denuncia**), **EMAVI** (municipales: acogida, empleo), **016** (24 h; no aparece en la factura, pero hay que **borrarlo del móvil**) y **112** (emergencias).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Agresión de una expareja sin convivencia = sí es violencia de género según la LO 1/2004.**

B4. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad de las personas trans y los derechos LGTBI

- **Despatologización**: ser persona trans no es una enfermedad; es tener una identidad sexual distinta del sexo asignado al nacer.
- **Autodeterminación (art. 16)**: acceso a la atención sanitaria y a tratamientos de afirmación de género **sin diagnósticos psiquiátricos** ni informes de "disforia".
- **Donación de sangre y tejidos**: prohibida la exclusión por orientación o identidad; solo por **conductas de riesgo individuales** con base científica.
- **Art. 17**: **prohibidas las terapias de conversión**, **incluso con consentimiento** del interesado; es infracción **muy grave**.
- **Art. 18**: acceso equitativo a la **reproducción asistida** y enfoque no heteronormativo.
- **Art. 19 · personas intersexuales**: **< 12 años**: **prohibida** la modificación genital, salvo indicación médica para proteger la salud física; **12-16 años**: solo a **petición expresa del menor** y con madurez certificada (no basta la voluntad de los padres).
- Infracción por **victimización secundaria** (trato inadecuado o trabas). Formación obligatoria del personal.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Menores intersexuales: la barrera es **12 años**, no los 16 de la mayoría de edad sanitaria.